当院での術中迅速病理組織標本作製におけるタスクシフトの取り組みと成果

◎瀬嵜 翔太[1)]、石田 悠希[1)]、水野 章吾[1)]、加藤 好洋[1)]、宮崎 恵子[1)]、直田 健太郎[1)]
聖隷浜松病院[1)]

【背景】働き方改革を背景に、当院病理検査室では病理医から臨床検査技師へのタスクシフトを推進している。当院では常勤病理医 1 名で年間約 14,000 件の組織診断と約 500 件の術中迅速組織診断に対応しており、業務負担の軽減が課題となっている。その対策として、組織診の切り出しにおけるタスクシフトは 2021 年より実施しており、更なる負担軽減策として、術中迅速組織標本作製における切り出しのタスクシフトの実践とその運用体制を構築したので報告する。

【方法】2024 年 4 月より、術中迅速組織標本作製における切り出しのタスクシフト導入を開始した。導入にあたり標準マニュアルを作成し、解剖学的知識や切り出しに関する問題演習を行うことで、各スタッフの知識向上を図った。さらに、病理医および認定病理検査技師が連携し、スタッフへ教育・指導を行った。対象は迅速件数の多いセンチネルリンパ節、脳腫瘍、婦人科腫瘍（子宮体癌、卵巣腫瘍など）を中心に進めた。また半年ごとに症例の見直しを行い、切り出し内容および診断結果のフィードバックを通じてスタッフの知識定着を実施した。

【結果】従来は迅速検体到着後、病理医へ連絡し、切出対応のための到着を待機していたが、本取り組みにより技師主体で迅速に切り出しを開始できる体制を確立した。これにより、病理医は他業務を中断することなく、術中迅速組織診断に専念でき、業務負担の軽減に寄与した。タスクシフト実施率は 2024 年度 303 件/508 件（59.6%）、2025 年度は 347 件/522 件（66.4%）であった。品質面では、センチネルリンパ節において凍結標本と永久標本の診断一致率は、導入前が 97.9%、導入後は 98.1%であり、導入前後で診断一致率に大きな差は認められなかった。脳腫瘍や婦人科腫瘍に関しても、診断上重大な不一致例は認めなかった。

【総括】技師主体の体制を構築したことで、術中迅速組織標本作製における切り出しタスクシフト運用が可能となった。今後は現在の品質を保ちつつ対象検体を拡大し、更なる病理医業務負担の軽減に努めたい。

聖隷浜松病院 臨床検査部 連絡先 053-474-5875